

결정하기 전, 이것만 확인하세요

Q1 파열되면 모두 수술하나요?

나이보다 불안정성·동반 손상·활동 목표와 재활 반응을 봅니다.

Q2 봉합이 아니라 재건인가요?

손상 형태에 따라 다르지만 힘줄 이식건 재건을 많이 사용합니다.

Q3 언제 운동에 복귀하나요?

근력·점프·균형과 심리적 준비를 평가해 단계적으로 결정합니다.

바로 진료가 필요한 신호

- 무릎이 완전히 펴지지 않는 잠김 또는 큰 관절 내 출혈
- 발이 차갑거나 감각이 떨어지는 신경·혈관 증상

수술 권유를 받았더라도 다시 확인할 수 있습니다

수술 권유를 받았어도 다시 확인할 수 있습니다.
증상·진찰·영상이 맞는지, 비수술 선택지와 수술 범위를 설명합니다.



김동희 원장

정형외과 전문의 · 무릎
관절경·스포츠 손상

검사와 영상을 직접 설명하고 필요한
치료 범위를 상담합니다.

진료 전에 가져오세요

- 최근 영상 CD·판독지
- 치료·수술 이력
- 복용 중인 약·알레르기

대표 전화 031-328-0333

경기도 용인시 처인구 중부대로 1539

진료 일정은 방문 전 대표 전화로 확인해 주세요.

이 자료는 일반적인 환자 교육용입니다. 개인별 치료 계획은 진찰과 검사
결과에 따라 달라집니다.

환자·보호자용 치료 안내

무릎 전방 십자 인대 파열

무릎 불안정성과 활동 목표를 확인한 뒤 재활 또는
재건술을 선택합니다.



질환과 치료를 이해하기 위한 해부 그림

관절경 전방 십자 인대 재건술

스포츠 복귀 날짜보다 다시 다치지 않을 움직임과
근력 기준을 충족하는 것이 우선입니다.

01 질환·증상

전방 십자 인대는 정강뼈가 앞으로 밀리고 회전하는 것을 제어합니다. 파열되면 무릎이 빠지는 느낌과 반복 불안정성이 생길 수 있습니다.



이런 증상을 확인합니다

- 다칠 때 ‘뚝’ 소리와 빠른 부종
- 방향 전환 때 무릎이 빠지는 느낌
- 운동 복귀가 어렵고 반복되는 불안정성

진단의 핵심

영상만으로 수술을 결정하지 않습니다.
증상·진찰·영상이 같은 부위를 가리키는지 확인합니다.

02 치료 선택

증상·진찰·영상·치료 반응·회복 목표를 함께 보고 결정합니다.

먼저 해볼 치료

- 부기 감소와 무릎 펴기·굽히기 회복
- 근력·균형·착지 재활
- 활동 조절과 기능성 보조기

수술을 검토할 때

- 방향 전환 활동에서 불안정성이 반복
- 동반 반월상 연골판 손상 위험이 큼
- 재활 뒤에도 원하는 활동 수준을 유지하기 어려움

치료의 흐름

비수술 치료

기능 재평가

필요 시 수술

03 수술·회복

관절경 전방 십자 인대 재건술



- 가 관절경으로 동반 손상 확인
- 나 대퇴골·경골에 해부학적 터널 형성
- 다 힘줄 이식건을 통과시켜 고정

회복은 날짜보다 기능 기준으로

- 초기 | 부기 감소와 완전한 무릎 펴기 확보
- 중기 | 근력·균형·착지 조절과 달리기 준비
- 복귀 | 근력 대칭·기능 검사·심리적 준비 확인

알아둘 위험과 한계

감염, 혈전, 관절 강직, 앞무릎 통증, 이식건 재파열·이완, 추가 수술 가능성이 있습니다.